

Com base nos critérios do documento norteador relacionados à função hepática, uso de medicações e prevenção de câncer, seguem valores de referência sugeridos para parametrização do sistema.

Os valores podem variar conforme o laboratório, mas estes são amplamente utilizados em protocolos clínicos adultos.

Valores de Referência — Função Hepática

Exame	Valor de Referência Adulto	Sugestão de Alerta
TGO (AST)	10 a 40 U/L	> 40 U/L
TGP (ALT)	7 a 56 U/L	> 56 U/L
Gama GT (GGT) Mulheres	7 a 32 U/L	> 32 U/L
Gama GT (GGT) Homens	9 a 48 U/L	> 48 U/L
Bilirrubina Total	0,3 a 1,2 mg/dL	> 1,2 mg/dL
Bilirrubina Direta	até 0,3 mg/dL	> 0,3 mg/dL
Bilirrubina Indireta	0,2 a 0,8 mg/dL	> 0,8 mg/dL

Valores de Referência — PSA

Exame	Valor de Referência
PSA Total	até 4,0 ng/mL
PSA Livre/Total	> 25% normalmente benigno

Sugestão de Alerta

- PSA entre 4 e 10 ng/mL → alerta amarelo
- PSA > 10 ng/mL → alerta vermelho

Valores para Exames Preventivos

Papanicolau

Critério	Referência
Periodicidade	anual até 2 exames normais consecutivos
Após 2 exames normais	a cada 3 anos
Faixa etária	25 a 64 anos

Resultados anormais

- ASC-US
- LSIL
- HSIL
- NIC I, II, III

→ gerar alerta vermelho para acompanhamento.

Mamografia

Critério	Referência
Rastreamento padrão	50 a 69 anos
Periodicidade	a cada 2 anos

Sugestão de alerta

- Exame atrasado > 24 meses → alerta amarelo

Critérios Clínicos Importantes para o Sistema

Alteração Hepática Grave

Sugestão de alerta vermelho quando:

- TGO/TGP > 3x o limite superior
- Bilirrubina total > 2,0 mg/dL
- GGT persistentemente elevada
- Associação com hormonioterapia ativa

Monitoramento de Hormonioterapia

Critério	Frequência sugerida
TGO/TGP/GGT	a cada 3 a 6 meses
Bilirrubinas	a cada 6 meses
PSA (quando aplicável)	anual
Mamografia	conforme faixa etária
Papanicolau	conforme protocolo

Sugestão de Regras Automatizadas

Alerta Amarelo

- Exame preventivo atrasado
- Ausência de exames > 12 meses
- Alteração leve de enzimas hepáticas

Alerta Vermelho

- TGO/TGP > 3x referência
- PSA elevado
- Citologia alterada
- Associação hormonioterapia + hepatopatia
- Múltiplas alterações hepáticas persistentes